Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

Correction

Examen Blanc nº 3 PASS
UE 7 : SHS



Durée de l'épreuve : **1h30 (Temps majoré : 2h00)**

A LIRE AVANT DE COMMENCER L'EPREUVE

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom, et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices ne sont pas autorisées.
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉPREUVE

INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

Le sujet contient 8 pages numérotées de 1 à 8 et comporte 1 QROC et 1 commentaire.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Mot du RM :

Coucou les P1,

Félicitations, vous êtes venus à bout du dernier Tuto de SHS (snif je suis trop triste 🥲 et j'imagine que vous aussi). Vous êtes vraiment des gigas bg.

Vous pouvez être **hyper fiers de tout ce que vous avez accompli jusque-là** que ce soit en SHS ou dans les autres matières. Regardez tout le chemin parcouru pour en arriver là : d'abord la PR où très souvent vous vous disiez que c'était impossible de tout retenir, puis le Tuto 1, le 2 et maintenant le 3 où finalement ce que vous pensiez presque infaisable est devenu réalisable (oui oui vous connaissez maintenant une grande majorité des cours et il vous reste encore un peu de temps pour apprendre ceux que vous n'avez pas encore eu le temps de voir). Le semestre 1 est long et pourtant vous êtes encore là et rien que pour ça **BRAVOOOOO** !!!!!!!

Concernant le Tuto, celui-ci est représentatif de l'exam et le sujet du commentaire a été relu et validé par Mme Lellinger (merci beaucoup à elle d'ailleurs). La QROC portait sur les **inégalités sociales de santé**, un cours plutôt intéressant mais assez dense donc pas de panique si vous n'avez pas bien cerné tous les points de ce cours. Revoyez le tranquillement chez vous et ça devrait le faire (d'ailleurs vous avez surement remarqué mais ce cours est aussi un cours que l'on retrouve en SP avec bien sûr des aspects un peu différents).
Le commentaire, de son côté, était sur le **don d'organes**, un cours hyper concret qu'il est important d'avoir bien compris (j'espère que vous avez aimé le texte par ailleurs ;)).

Comme je vous le dis à chaque fois, **votre note au Tuto n'est pas votre note définitive que vous aurez le jour J** (comprenez bien cela parce que ça peut vous aider à déstresser un peu). Petite anecdote, l'an dernier, le commentaire du dernier Tuto portait sur un cours que je n'avais pas encore vu. J'ai donc fait la QROC puis essayé de faire le commentaire en commençant par l'introduction qui ne nécessite pas de connaître le cours et ensuite j'ai fait un développement assez bancal en essayant de m'aider des cours que j'avais vu et qui pouvaient se rattacher au sujet. Donc j'insiste sur ce point : **VOTRE NOTE DU TUTO NE SERA PAS FORCÉMENT CELLE QUE VOUS AUREZ À L'ÉXAM !!!!!!**

Alors lisez bien l'exemple de correction et la grille de correction et comme ça vous progresserez encore pour le jour J !!!!!!

Je vous souhaite **plein de courage** pour cette dernière ligne droite qui arrive avec la période de révisions. Donnez tout ce que vous avez (sans non plus finir HS, ça serait dommage de ne pas être en forme pour l'exam) ! **Vous êtes des bossssss !!!!**

Killian, Votre RM EB SHSuper triste d'arriver à la fin du semestre

QROC : Quelles sont les différentes barrières matérielles à l'accès au soin ? (10 lignes)

Cette partie est à rédiger sur votre copie, dans l'encart prévu à la QROC et au stylo à bille à encre noire. Merci de ne pas rédiger vos réponses au feutre, ce qui rend la copie quasi impossible à lire et donc à corriger.

Certaines disparités sociales en matière d'accès aux soins sont liées à des barrières matérielles. L'existence d'un **gradient social de santé** témoigne du fait que la position dans la hiérarchie sociale (revenus, études, profession) influe sur la santé, les personnes aisées étant généralement en meilleure santé que celles issues de milieux modestes. De fait, les **conditions de vie matérielles**, notamment la **salubrité du logement**, influent sur la facilité d'accès aux soins. Par ailleurs, la **prise en charge partielle des dépenses de santé** constitue un obstacle majeur pour les populations précaires, qui renoncent parfois à se soigner faute de moyens. Enfin, les **obstacles bureaucratiques**, tels que la complexité de l'ouverture des droits à l'Aide Médicale d'État (AME), découragent les démarches administratives nécessaires pour accéder aux soins.

COMMENTAIRE DE TEXTE :

Cette partie est à rédiger sur votre copie, dans l'encart prévu au commentaire de texte et au stylo à bille à encre noire. Merci de ne pas rédiger vos réponses au feutre, ce qui rend la copie quasi impossible à lire et donc à corriger.

"Les premières greffes d'organes ont débuté dans les années 50 pour connaître un essor rapide à partir de la décennie 60 et de la découverte de l'immunosuppression. Cependant, le développement de cette technique, dont l'enjeu est essentiel puisqu'il s'agit du maintien de la vie, est freiné par le manque de disponibilité des organes.

[...] Ainsi, en 2010 la commission européenne a estimé à 60000 le nombre de personnes en attente d'une transplantation d'organes. De l'attente qui se prolonge, calculée à 3 années théoriques, résultent des décès, environ 12 par jours.

Les protocoles organisant le don d'organes diffèrent selon les pays. D'une façon générale, il existe deux types de don : donneur décédé, donneur vivant. En ce qui concerne les personnes décédées, différents profils de donneurs sont possibles : donneur décédé en état de mort encéphalique, donneur décédé après arrêt circulatoire suite à un arrêt cardiaque inopiné appelés « Maastricht II » selon la classification internationale de Maastricht, donneur décédé après arrêt circulatoire contrôlé suite à la limitation ou l'arrêt des thérapeutiques dénommés « Maastricht III » selon cette même classification. [...] Quoiqu'il en soit, le prélèvement d'organes n'est réalisé que lorsque la mort est constatée et le certificat de décès signé. Le cas de figure du donneur vivant, 10 % des dons, concerne essentiellement la greffe rénale. Le principe est le suivant : une personne majeure, vivante, volontaire et en bonne santé peut donner un rein dans les conditions définies par la loi de bioéthique du 7 juillet 2011."

Geneviève Pinganaud, "Donner et recevoir un organe : réflexion éthique autour du prélèvement", *Revue de Bioéthique de Nouvelle-Aquitaine*, 2018, 1, p. 17-22, hal-02536932.

Consigne : À partir du texte et de vos connaissances, expliquez comment la transplantation d'organes s'est mise en place au XXème siècle, puis vous décrirez ses grands principes, enfin donnez les modalités du don post-mortem et du don vivant.

Correction du commentaire de texte :

Dans certaines pathologies, les traitements conventionnels ne suffisent pas pour sauver un patient. C'est dans ce contexte que le don d'organes s'est développé et est maintenant essentiel. C'est de cela que Geneviève Pinganaud nous parle dans son texte de nature médicale, intitulé "Donner et recevoir un organe : réflexion éthique autour du prélèvement" issu de la *Revue de Bioéthique de Nouvelle-Aquitaine* et publié en 2018. Ainsi, ce texte traite de la mise en place du don d'organes dans la deuxième moitié du XXe siècle ainsi que de ses différentes modalités. Nous nous demanderons donc comment s'est développé le don d'organes et quelles sont les spécificités pour en bénéficier. Ainsi, l'auteur cherche à montrer que le don d'organes s'est développé dans les années 50 et qu'il est conditionné par la disponibilité des organes. Enfin, il nous explique qu'il y a deux types de dons, avec d'un côté les donneurs décédés et d'un autre côté les donneurs vivants.

Le don d'organes est une activité qui se développe tout d'abord en l'absence d'alternative viable à partir des "années 50" (ligne 1). Cette période est en effet marquée par le début de la médecine expérimentale efficace avec le développement des immunosuppresseurs par exemple. Toutefois, même si la médecine progresse fortement, on retrouve encore une impasse thérapeutique pour les défaillances isolées d'organes vitaux. Prenons l'exemple de l'insuffisance rénale terminale. Cette pathologie ne possède pas de traitement, on se retrouve donc un enjeu vital puisque la vie du sujet est engagée. De plus, les expérimentations sur le sujet sont catastrophiques. On voit alors apparaître simultanément deux pistes thérapeutiques. D'un côté, on retrouve l'idée du rein artificiel et d'un autre côté se développe l'idée de la transplantation rénale.

Le premier succès de greffes réalisé à partir d'organes prélevés chez des donneurs décédés a lieu dans les années 60, période durant laquelle le don d'organes connaît son essor (ligne 2). Dans les années 70, la technique du don d'organes se développe ce qui permet un succès prolongé des greffes et une demande accrue de la part des patients. Enfin, c'est dans les années 90 qu'est démontrée l'amélioration de la qualité et de la durée de vie des greffés.

Pour continuer, nous allons voir les grands principes du don d'organes. Premièrement, il s'agit d'une médecine substitutive puisque l'on remplace un organe vital qui est détruit de manière irréversible à cause d'une maladie chronique ou d'un accident par un autre organe vital provenant d'un autre être vivant. Ce don d'organes s'oppose au système immunitaire physiologique d'où l'utilisation d'immunosuppresseurs pour limiter les rejets de greffe.

Ensuite, il est important de noter qu'aujourd'hui on peut greffer différents types d'organes. Ainsi, des greffes d'organes solides comme le cœur peuvent être réalisées. On peut également greffer des tissus comme la peau, des cellules comme les cellules souches hématopoïétiques ou encore des tissus composites comme le pénis.

Enfin, les sources d'organes sont diverses. Ils peuvent provenir de personnes vivantes (ligne 9) pour ce qui est du rein, du foie, de la peau ou des poumons dans certains cas. Mais ils peuvent également provenir de personnes décédées et cela pour tous les types d'organes. De plus, il existe aussi la xéno-transplantation qui consiste à utiliser l'organe d'un animal mais cette dernière est très marginale et surtout encore au stade d'expérimentation. Enfin, le prélèvement d'organes s'inscrit dans une chaîne de solidarité interhumaine puisque si personne ne donne ses organes alors il n'y a pas d'organes disponibles et donc pas de possibilité de greffe comme c'est évoqué ce qui amène à la pénurie comme évoqué aux lignes 3 et 4.

Pour terminer, il existe deux types de dons (ligne 9) possédant chacun leurs particularités. D'ailleurs, un des enjeux bioéthiques du don d'organes est de prendre en compte ces particularités. Le premier type de don est le don entre vivants et le second type est le don post-mortem soit avec un donneur décédé. Dans les 2 cas, il s'agit bien sûr d'une solidarité interhumaine et il faut s'assurer du respect de la dignité humaine.

Ainsi concernant le don entre vivants il faut s'assurer de l'absence de contre-indication. Les médecins doivent expliciter clairement les différents risques au patient et au donneur et le consentement doit être explicite (ligne 17), on parle de "opt-in". Il faut aussi que le don soit gratuit, jamais on ne vend ses organes mais il s'agit bien d'une solidarité entre personnes. De plus, le don doit être dirigé c'est-à-dire que le donneur doit donner à une personne qu'il connait sauf dans le cas des dons croisés. Le principe du don croisé est le suivant : en cas d'incompatibilité entre le donneur et le receveur qui se connaissent et qui rend donc impossible la greffe, il est possible de faire un don croisé c'est-à-dire entre deux couples donneur/receveur (on peut aller jusqu'à six couples depuis la loi de 2021). Ainsi le donneur du couple A donne son organe au receveur du couple B et inversement. Le donneur doit être majeur (don interdit aux mineurs) (ligne 17). Les dons entre vivants sont régis par les lois de bioéthique (ligne 18) dont la dernière est celle de 2021. Ces lois, au fur et à mesure de leur évolution, permettent d'accroître les potentiels donneurs.

Concernant les dons post-mortem, il faut absolument respecter le corps de la personne décédée et respecter la volonté du défunt, le consentement est ici présumé, on parle de "opt-out". Si une personne ne veut pas donner ses organes une fois décédée, elle peut s'inscrire sur le registre national des refus à partir de 13 ans ou tout simplement faire part de sa volonté à ses proches. Par ailleurs, il est très important de respecter et d'accompagner les proches du donneur décédé. À noter que la gratuité du don est extrêmement importante tout comme l'anonymat entre le donneur et le receveur.

D'autre part, "en ce qui concerne les personnes décédées, différents profils de donneurs sont possibles" (lignes 9 et 10). On distingue ainsi deux types de mort : le décès en état de mort encéphalique c'est-à-dire à cœur battant et le décès après arrêt circulatoire c'est-à-dire à cœur non battant. Ainsi, lors d'un décès en état de mort encéphalique, il y a plusieurs étapes à suivre. Il faut tout d'abord éliminer les diagnostics différentiels avec notamment la recherche de toxiques. Ensuite, un diagnostic clinique est effectué après reconstitution précise des

circonstances de décès et l'absence de toute conscience et mobilité spontanée. Il faut donc vérifier l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et l'absence de toute ventilation spontanée. Enfin, il y a une confirmation para clinique qui passe par deux électroencéphalogrammes qui doivent être nuls et aréactifs ou la réalisation d'une artériographie cérébrale. Maintenant, concernant les décès après arrêt circulatoire, plusieurs circonstances sont possibles et sont classées selon la classification de Maastricht (ligne 12). En effet, le donneur peut être décédé après un arrêt cardiaque inopiné et réfractaire après trente minutes de manœuvres de réanimation bien conduite. On parle alors de catégories I et II de Maastricht (lignes 10 à 12). Ensuite, la catégorie III de Maastricht correspond au "donneur décédé après arrêt circulatoire contrôlé suite à la limitation ou l'arrêt des thérapeutiques" (lignes 12 et 13). Enfin la catégorie IV correspond à l'arrêt circulatoire irréversible alors que la personne est décédée en mort encéphalique. De la même manière que pour les dons entre vivants, les dons post-mortem sont encadrés par les lois de bioéthique.

En conclusion, le don d'organes s'est développé à partir des années 50 dans un contexte d'impasse thérapeutique et la technique s'est perfectionnée avec le temps pour avoir toujours moins de rejets. De grands principes sont à respecter dont le respect de la dignité humaine par exemple. Enfin, il existe deux types de dons : le don entre vivants et le don post-mortem qui peut se subdiviser en sous-catégories de donneurs. Toutefois, un des enjeux majeurs actuels concernant les dons d'organes est la pénurie qui fait ainsi augmenter les listes d'attente et donc diminue les chances de survie de certains patients. Cette pénurie peut notamment s'expliquer par une hausse des refus. Des solutions doivent donc être trouvées pour permettre à ceux qui en ont besoin de pouvoir bénéficier d'un nouvel organe.

Ce sujet a été réalisé par :

Rédacteurs : Aldo RUCINE (DFGSM2, RM GT Chimie PASS 2024-2025), Killian MADEJ (DFGSM2, RM EB SHS PASS 2024-2025), Simon COMMENAY-LE ROUX (DFGSM2, RM GT SHS PASS 2024-2025)

Relecteurs : Marwa BELAHSEN (L.AS 3 Chimie), Killian MADEJ (DFGSM2, RM SHS EB PASS 2024-2025)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la Secte Hyper Sexe**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université.

Sous la coordination de Killian MADEJ (DFGSM2, RM SHS EB PASS 2024-2025) et Simon COMMENAY-LE ROUX (DFGSM2, RM SHS GT PASS 2024-2025)

Prenez votre copie en photo avant de la rendre et n'oubliez pas de scanner le QRcode

Votre note et classement sont disponibles sur le site ***www.a2sup.fr***
Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre copie sur l'adresse suivante:
grilles@a2sup.fr

A2SUPforum

L'A2SUP répond à toutes vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

⚠️Les bases du forum⚠️

Question de cours : Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question	Utiliser la **loupe** (en haut à droite) Chercher le bon topic	**Question Exos/Annales :** QXX (mettre les 2 chiffres ex : Q03) Énoncé Question

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP